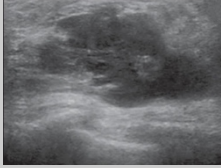
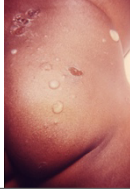


Type d'infection	Pathogènes les plus courants	Implication tissulaire	Caractéristiques cliniques	Diagnostic	Traitement
Non purulent	Érysipèle	<u><i>S. pyogenes</i> (GAS)</u>	Derme superficiel Vaisseaux lymphatiques 	<u>Lésion érythémateuse, surélevée et bien délimitée</u> , souvent sur les membres inférieurs ou le visage Clinique Pas besoin d'imagerie.	Antibiotiques (pénicilline) Gestion des FR.
	Cellulite	<u><i>S. pyogenes</i> (GAS)</u> <u><i>S. aureus</i></u>	Derme profond Tissu sous-cutané 	<u>Lésion érythémateuse mal définie, peau d'orange, douleur, fièvre</u> FSC, CRP Imagerie en cas de complications.	Antibiotiques Soins de soutien.
Purulent	Abcès	<u><i>S. aureus</i> (SMRSA)</u>	Tissus sous-cutanés  	<u>Nodule douloureux</u> , fluctuant avec <u>collection de pus</u> , <u>soulagement après drainage</u> 	Incision et drainage Antibiotiques si infection sévère.
	Folliculite Furoncle Carbuncle	<u><i>S. aureus</i></u> <u><i>P. aeruginosa</i> (jacuzzi)</u>	<u>Follicules pileux</u> <u>Papules prurigineuses, pustules, nodules douloureux, nécrose possible pour les carbuncles</u> Folliculite Furoncle Carbuncle   	Clinique US si nécessaire.	
Autre	Impétigo	<u><i>S. aureus</i></u> <u><i>S. pyogenes</i> (GAS)</u>	Épiderme superficiel <u>Lésions croûteuses jaunâtres, très contagieuses</u> Non-bulleux Bulleux  	Clinique <u>Cultures</u> dans les cas récalcitrants.	Antibiotiques topiques (mupirocine) Antibiotiques systémiques si sévère.
	Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)	<u><i>S. aureus</i> (exotoxine)</u>	Épiderme superficiel <u>Érythème généralisé, décollement cutané, fièvre, douleur</u>	Clinique <u>Biopsie cutanée</u> pour confirmation.	Antibiotiques systémiques Soins de soutien en milieu hospitalier.

						
Nécrosant Polymicrobien : <u>GAS</u> + <u>Anaérobique</u>	Cellulite nécrosante Fasciite nécrosante	<i>S. pyogenes (GAS)</i> <i>S. aureus</i> <i>Clostridium spp.</i>	<i>Fascia superficielle et profonde</i> <i>Tissu sous-cutané</i>	<u>Douleur disproportionnée</u> , érythème, <u>crépitus</u> , <u>bulles</u> , <u>nécrose cutanée</u> 	<u>Leucocytose, CK élevée</u> <u>Gaz au CT/Rx</u> <u>Cultures tissulaires</u>	<u>Débridement chirurgical</u> <u>Antibiotiques large spectre</u> <u>Soins intensifs</u> <u>URGENT</u>
	Gangrène de Fournier	<u>Polymicrobien :</u> <i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> <i>Enterococcus</i> <i>Anaérobies</i>	<u>Organes génitaux externes</u> <u>Abdomen antérieur</u> <u>Muscles fessiers</u>	<u>Douleur génitale</u> , gonflement, <u>crépitus</u> , <u>nécrose rapide</u> 		
	Myosite nécrosante	<i>Clostridium perfringens</i> <i>S. pyogenes (GAS)</i>	<u>Muscle</u>	<u>Douleur musculaire sévère</u> , gonflement, fièvre		
	Gangrène gazeuse	<u><i>Clostridium perfringens</i></u> , <i>Clostridium septicum</i>		<u>Douleur musculaire</u> , <u>crépitus</u> , <u>décoloration de la peau</u> , <u>bulles</u> 		

Infections non purulentes *S. pyogenes* (GAS)

Érysipèle

Épidémiologie :

- ?
- Courant chez les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques.

Étiologie :

- ?
- S. pyogenes* (GAS) est le pathogène principal.

Facteurs de risque :

- ?
- Plaies cutanées mineures, maladies chroniques (diabète, lymphœdème).

Symptômes :

- ?
- Lésion érythémateuse, surélevée et bien délimitée, souvent sur les membres inférieurs ou le visage.

Diagnostic :

- ?
- Basé sur les signes cliniques, imagerie non nécessaire.

Traitement :

- ?
- Antibiotiques actifs contre les streptocoques (pénicilline).
- ?
- Surveillance des facteurs de risque.



Cellulite

Épidémiologie :

- ?
- Fréquente chez les adultes avec des comorbidités comme le diabète.

Étiologie :

- ?
- S. pyogenes* (GAS) (Non-purulent) et *S. aureus* (purulent).

Facteurs de risque :

- ?
- Plaies, ulcères, immunosuppression.

Symptômes :

- ?
- Lésion érythémateuse mal définie, peau d'orange, douleur, fièvre.

Diagnostic :

- ?
- Clinique, NFS, CRP, imagerie pour les cas graves.

Traitement :

- ?
- Antibiotiques, soins de soutien.



Infections purulentes *S. aureus*

Abcès

Épidémiologie :

- ?
- Fréquents, surtout chez les patients immunodéprimés.

Étiologie :

- ?
- S. aureus*, souvent MRSA.

Facteurs de risque :

- ?
- Immunodépression, diabète, antécédents d'infections cutanées.
- ?
- Traumatismes cutanés, obésité.

Symptômes :

- ❓ Nodule rouge, douloureux, fluctuant avec pus.
- ❓ Douleur souvent soulagée après drainage spontané ou chirurgical.
- ❓ Peut être entouré d'érythème et d'induration.



Diagnostic :

- ❓ Clinique.
- ❓ Laboratoire : NFS (leucocytose), cultures du pus.
- ❓ Imagerie : Échographie pour confirmer la présence de pus.

Traitement :

- ❓ Incision et drainage sont les traitements de choix.
- ❓ Antibiotiques systémiques si infection sévère ou si immunodéprimé.

Folliculite, Furuncle, Carbuncle

Épidémiologie :

- ❓ Survient souvent après une friction ou un traumatisme cutané.

Étiologie :

- ❓ S. aureus, P. aeruginosa.

Facteurs de risque :

- ❓ Occlusion des follicules, immunosuppression.

Symptômes :

- ❓ Papules, pustules, nodules douloureux, nécrose possible.



Diagnostic :

- ❓ Clinique, échographie si nécessaire.

Traitement :

- ❓ Incision et drainage, antibiotiques si infection sévère.

Autres infections

Impétigo

Épidémiologie :

- ❓ Très contagieux, surtout chez les enfants. Épiderme superficiel.

Étiologie :

- ❓ S. aureus (Bulleux et Non-bulleux)
- ❓ S. pyogenes (GAS) (Non-bulleux).

Symptômes :

- ❓ Signe de Nikolsky négatif pour les deux types.
- ❓ **Impétigo non-bulleux** (~ 70%) :
 - ❓ S. aureus, S. pyogenes (GAS)
 - ❓ Papules qui évoluent en vésicules et pustules, se rompent, puis forment des croûtes couleur miel (qui guérissent sans cicatrice).
 - ❓ Prurit possible mais douleur rare.
 - ❓ Principalement visage (en particulier autour du nez et de la bouche, et extrémités).
 - ❓ Adénopathies locales.
- ❓ **Impétigo bulleux** (~ 30%) :



- ❓ **S. aureus**
- ❓ *Vésicules* qui se transforment en *grandes bulles flasques*, se *rompent* et forment des *croûtes fines brunes*.
- ❓ *Tronc* et *extrémités supérieures*.
- ❓ *Signes systémiques* dans les cas graves (fièvre, malaise).
- ❓ Peut se compliquer en **SSSS**

Diagnostic :

- ❓ *Clinique*, *Signe de Nikolsky négatif*.
- ❓ *Culture* si réfractaire.

Traitement :

- ❓ *Antibiotiques topiques* (*mupirocine, ac. fucidique*) ou *systémiques*.

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)

Épidémiologie :

- ❓ Affecte principalement les nouveau-nés et jeunes enfants < 6 ans. *Épiderme superficiel*.

Étiologie :

- ❓ **S. aureus** : *Exotoxine*.

Symptômes :

- ❓ Précédé d'une infection à **S. aureus** (gastro. ou pharyngite) / d'un **Impétigo bulleux**.
- ❓ *Érythème généralisé, décollement cutané, fièvre, douleur*.
- ❓ *Ne touche pas les muqueuses*.

Diagnostic :

- ❓ *Clinique*, *Signe de Nikolsky positif*.
- ❓ *Biopsie* pour confirmation.

Traitement :

- ❓ Antibiotiques systémiques, soins en milieu hospitalier.



Infections nécrosantes des tissus mous

Cellulite nécrosante et Fasciite nécrosante

Épidémiologie :

- ❓ Infections rares mais graves nécessitant une prise en charge urgente.

Étiologie :

- ❓ Polymicrobienne (E. coli, Bactéroïdes spp.) ou monomicrobienne (S. pyogenes, S. aureus, Clostridium spp.).

Facteurs de risque :

- ❓ Immunosuppression, diabète, traumatismes.

Symptômes :

- ❓ Douleur disproportionnée, érythème, crépitus, bulles, nécrose.

Diagnostic :

- ❓ **Laboratoire** : Leucocytose, hyperglycémie, CRP élevée, CK élevée.
- ❓ **Microbiologie** : Hémocultures, cultures de tissus profonds.
- ❓ **Imagerie** : Gaz au CT/Rx, épaissement fascial, absence de rehaussement au contraste.

Traitement :

- ❓ Débridement chirurgical immédiat, antibiotiques large spectre, soins intensifs.



Gangrène de Fournier

Épidémiologie :

- ❓ Fasciite nécrosante des organes génitaux externes d'origine polymicrobienne.

Étiologie :

- ❓ Infection mixte avec des pathogènes facultatifs et anaérobies.

Facteurs de risque :

- ❓ Diabète, alcoolisme, immunosuppression.

Symptômes :

- ❓ Douleur génitale sévère, gonflement, crépitus, nécrose rapide.

Diagnostic :

- ❓ Similaire à la fasciite nécrosante.

Traitement :

- ❓ Débridement chirurgical agressif, antibiotiques large spectre, soins de support intensif.



Myosite nécrosante

Épidémiologie :

- ❓ Infection grave des muscles, souvent causée par Clostridium perfringens.

Étiologie :

- ❓ Clostridium perfringens, Streptococcus pyogenes, S. aureus.

Facteurs de risque :

- ❓ Traumatismes, chirurgies récentes.

Symptômes :

- ❓ Douleur musculaire sévère, gonflement, crépitus, fièvre.

Diagnostic :

- ❓ **Laboratoire** : Leucocytose, CK élevée.
- ❓ **Imagerie** : Gaz au CT/Rx.
- ❓ **Microbiologie** : Identification de Clostridium spp.

Traitement :

- ❓ Débridement chirurgical, antibiothérapie empirique, soins intensifs.

Gangrène gazeuse

Épidémiologie :

- ❓ Infection rapidement progressive des muscles due à Clostridium spp.

Étiologie :

- ❓ Clostridium perfringens, Clostridium septicum.

Facteurs de risque :

- ❓ Traumatismes, chirurgie récente, immunosuppression.

Symptômes :

- ❓ Douleur musculaire intense, crépitus, décoloration de la peau, bulles.

Diagnostic :

- ❓ **Laboratoire** : Leucocytose, CK élevée.
- ❓ **Imagerie** : Gaz dans les tissus mous (CT/Rx).
- ❓ **Microbiologie** : Identification de Clostridium spp.

Traitement :

- ❓ Débridement chirurgical immédiat, antibiothérapie empirique, soins intensifs.